فلوچارت تصمیم‌گیری بالینی: تومورهای ادنتوژنیک فکین

تریاژ رادیوگرافیک، استراتژی بیوپسی، پروتکل‌های رزکسیون بر اساس مارجین و فالوآپ

تظاهر بالینی و رادیوگرافیک: اتساع فک و لوسنسی کورتیکه‌دار ( )
اکسپنشن باکال/لینگوال ● لوسنسی تک یا چندحفره‌ای ( ) ● تحلیل ریشه

↓

مرحله ۱ الزامی: تصویربرداری سه‌بعدی با و آسپیراسیون سوزنی ()
بررسی پرفوراسیون کورتکس ● رد مالفورماسیون عروقی و کیست‌ها با آسپیراسیون خشک ( )

↓

موتواک/اپک؟ — **بله (ترکیبی)** → **تومور پین‌بورگ ()**
کلسیفیکاسیون با ماده آمیلوئیدی؛
انوکلئیشن با مارجین
یا رزکسیون محدود

خیر (لوسنت) ↓

بیوپسی برشی ترانس‌اورال الزامی ( ) در حاشیه بافت سالم/ضایعه
پرهیز از انوکلئیشن زودرس کورکورانه بدون تشخیص پاتولوژی قطعی ( )

↓

تشخیص پاتولوژی

میکسومای ادنتوژنیک	آملوبلاستوما سالید/مولتی	آملوبلاستوما تک‌کیستی	تومور آدنوماتوئید ()
استرومای میگزوئید فاقد کپسول	نفوذ به مغز استخوان	لومینال یا اینترالومینال	قدام ماگزیلا، دور تاج نهفته
عود با انوکلئیشن:	عود با کورتاژ:	عود با کورتاژ:	کپسولار و خوش‌خیم؛
			عود: $< 1\%$
رزکسیون مارجینال/سگمنتال	**رزکسیون قطعی استخوانی**	**انوکلئیشن + ادجوانت**	**انوکلئیشن + کورتاژ ظریف**
مارجین استخوانی ۱۰ میلی‌متر	رزکسیون مارجینال/سگمنتال	استکتومی محیطی ۱ تا ۲ میلی‌متر	خارج‌سازی با دندان درگیر
حذف حاشیه وسیع	**مارجین استخوان ۱۰ تا ۱۵ میلی‌متر**	یا کاربرد محلول کارنوی ()	جداسازی تمیز کپسول از استخوان
به علت نفوذ ژلاتینی	همراه با یک لایه بافت نرم سالم		
زمان‌بندی پیگیری:	**زمان‌بندی پیگیری:**	**زمان‌بندی پیگیری:**	**زمان‌بندی پیگیری:**
هر ۶ ماه تا ۵ سال	**هر ۶ ماه تا ۵ سال**	**هر ۶ ماه تا ۵ سال**	**سالیانه تا ۲ سال**
پایش دقیق عود لوسنت تا ۱۰ سال	سپس سالیانه به صورت مادام‌العمر	سپس سالیانه تا ۱۰ سال	معاینه کلینیکی و رادیوگرافی

↓

هشدارهای تشخیصی و معیارهای کلیدی انحراف درمان ( ):

(۱) اگر پاتولوژی آملوبلاستوم تک‌کیستی، نفوذ مورال () نشان دهد، درمان بلافاصله به رزکسیون ارتقا می‌یابد ● (۲) کورتاژ در تومور سالید ممنوع **ملاحظات حیاتی:** است ● (۳) جهش در بیش از ۸۰٪ آملوبلاستوماهای مندیبل وجود دارد.

↓

پروتکل افزایش گام‌به‌گام درمان () برای موارد عودکننده / پرفوراسیون کورتکس:

اکسیزیون پریوست و مخاط روی استخوان همراه با رزکسیون سگمنتال مندیبل. **سطح ۳ (پرفوراسیون کورتکس):**
رزکسیون قطعی با مارجین بافت نرم سالم ۵ تا ۱۰ میلی‌متر و بازسازی همزمان با . **سطح ۴ (عود مکرر جراحی):**
مهارکننده‌های هدفمند (دابرافنیب + ترامتینیب) جهت کاهش حجم ضایعه. **سطح ۵ (غیرقابل جراحی / قاعده جمجمه):**